



Comprendre Alzheimer au quotidien

Reconnaître, accompagner, protéger

Guide offert · édition 2026

Youdom Care — Aide à domicile à Paris & Île-de-France · 01 84 80 72 97 · youdom-care.com

La maladie d'Alzheimer touche plus de 900 000 personnes en France et bouleverse la vie de familles entières. Face à la perte de mémoire, aux troubles du comportement et à la désorientation, les proches se sentent souvent démunis. Pourtant, comprendre la maladie et adopter les bonnes attitudes change profondément le quotidien, tant pour la personne malade que pour son entourage. Ce guide vous donne des repères clairs sur l'évolution de la maladie et des méthodes concrètes, humaines et bienveillantes pour accompagner sans s'épuiser.

01 Les 7 stades de la maladie

La maladie d'Alzheimer évolue progressivement. L'échelle de Reisberg décrit sept stades, du fonctionnement normal (stade 1) au déclin très sévère (stade 7). Les stades 2 et 3 correspondent à un déclin cognitif très léger puis léger : oublis bénins, difficultés à retrouver ses mots ou à se concentrer, souvent attribués à tort au vieillissement normal. C'est à ce moment qu'un diagnostic précoce, précieux, peut être posé.

Le stade 4 (déclin modéré) marque l'entrée dans la maladie manifeste : difficultés à gérer ses finances, à préparer un repas, oubli d'événements récents. Le stade 5 (déclin modérément sévère) rend l'aide quotidienne nécessaire : la personne peut oublier son adresse, avoir besoin d'aide pour s'habiller. Aux stades 6 et 7, l'accompagnement devient permanent : perte de reconnaissance des proches, troubles du comportement marqués, puis perte de la marche, de la parole et de l'autonomie physique.

Connaître ces stades aide à anticiper les besoins plutôt que de subir les crises : adapter le logement, organiser les aides, prendre les décisions juridiques (mesures de protection, directives anticipées) au bon moment. Chaque personne évolue à son rythme ; ces repères sont des tendances, non un calendrier figé. Le neurologue et l'équipe soignante restent les meilleurs guides pour situer la progression.

À RETENIR

- L'échelle de Reisberg décrit 7 stades, du fonctionnement normal au déclin très sévère.
- Un diagnostic précoce (stades 2-3) permet d'anticiper et de mieux accompagner.
- L'aide quotidienne devient nécessaire à partir du stade 5.
- Anticiper les décisions juridiques et l'organisation des aides selon le stade.

02 Adapter la communication (méthode Humanitude)

Communiquer avec une personne atteinte d'Alzheimer demande d'abandonner nos réflexes habituels. La méthode Humanitude, développée par Yves Gineste et Rosette Marescotti, repose sur quatre piliers : le regard, la parole, le toucher et la verticalité. Regarder la personne à sa hauteur, dans les yeux, de face, établit un lien avant même de parler. Une parole douce, lente, accompagnée de mots simples et d'un ton chaleureux, rassure.

Le toucher relationnel — une main posée délicatement, un geste enveloppant plutôt que saisissant — transmet la sécurité quand les mots ne suffisent plus. Préserver la verticalité, c'est-à-dire aider la personne à rester debout et mobile le plus longtemps possible, entretient la dignité et l'autonomie. Ces gestes préviennent aussi les comportements d'agitation liés à la peur ou à l'incompréhension.

Au quotidien, quelques principes aident : annoncer chaque geste avant de le faire, laisser le temps de répondre, ne jamais infantiliser, éviter les questions qui mettent en échec (« tu te souviens de... ? »). Privilégiez les phrases courtes, un environnement calme sans bruit ni sur-stimulation, et acceptez de rejoindre la réalité de la personne plutôt que de la corriger sans cesse.

À RETENIR

- Humanitude : regard à hauteur, parole douce, toucher relationnel, verticalité.
- Annoncer chaque geste avant de le réaliser et laisser le temps de répondre.
- Éviter les questions qui mettent en échec et ne jamais infantiliser.
- Privilégier un environnement calme, sans sur-stimulation.

03 La méthode Montessori adaptée Alzheimer

Inspirée de la pédagogie de Maria Montessori, la méthode Montessori adaptée aux personnes atteintes de troubles cognitifs vise à préserver l'autonomie, l'estime de soi et le sens de l'utilité. Le principe : s'appuyer sur les capacités préservées plutôt que de pointer les pertes, en proposant des activités porteuses de sens, adaptées aux goûts et à l'histoire de la personne.

Concrètement, il s'agit de permettre à la personne de « faire » plutôt que de « faire à sa place » : plier du linge, mettre la table, arroser des plantes, trier des objets, cuisiner un geste simple. Ces activités mobilisent la mémoire procédurale, souvent longtemps préservée, et procurent satisfaction et apaisement.

L'environnement est aménagé pour favoriser l'autonomie : repères visuels, objets accessibles, consignes simples affichées.

Cette approche réduit l'apathie, l'agitation et les troubles du comportement en redonnant du rôle et du plaisir. Elle valorise chaque réussite, aussi modeste soit-elle, et respecte le rythme de la personne. Adaptée à chaque étape de la maladie, elle transforme des moments de soin subis en moments de vie partagés, bénéfiques aussi pour l'aidant.

À RETENIR

- S'appuyer sur les capacités préservées, pas sur les pertes.
- Proposer des activités qui ont du sens : plier, trier, cuisiner, jardiner.
- Solliciter la mémoire procédurale, souvent longtemps intacte.
- Aménager l'environnement avec repères visuels et objets accessibles.

04 Gérer les troubles du comportement

Agitation, agressivité, cris, déambulation, refus de soin, accusations : les troubles du comportement sont fréquents et éprouvants. Il est essentiel de comprendre qu'ils ne sont pas dirigés contre l'aidant ; ils traduisent une souffrance, une peur, un inconfort ou un besoin non exprimé. La personne ne « fait pas exprès » : la maladie altère sa capacité à comprendre et à s'exprimer.

La première réponse est de chercher la cause : douleur, faim, soif, besoin d'aller aux toilettes, fatigue, environnement bruyant, ennui, changement de routine. Souvent, corriger l'inconfort fait cesser le trouble. En cas d'agitation, restez calme, ne contre-argumentez pas, ne haussez pas le ton ; détournez l'attention vers une activité ou un sujet apaisant (la diversion est très efficace). Validez l'émotion (« je vois que tu es contrarié ») plutôt que de nier la réalité de la personne.

Maintenez des routines stables et rassurantes, un environnement calme et une lumière adaptée. Notez les circonstances des crises pour repérer des déclencheurs récurrents. Si les troubles s'intensifient, consultez le médecin pour écarter une cause physique (infection, douleur, effet médicamenteux). Évitez autant que possible les sédatifs, à réserver aux situations sévères et sur avis médical.

À RETENIR

- Les troubles expriment une souffrance ou un besoin, pas une intention hostile.
- Chercher et corriger la cause : douleur, faim, fatigue, environnement.
- Rester calme, ne pas contre-argumenter, utiliser la diversion.
- Consulter le médecin en cas d'aggravation pour écarter une cause physique.

05 Sécuriser le domicile (errance, fugue)

L'errance et le risque de fugue comptent parmi les préoccupations majeures des familles. La personne peut vouloir « rentrer chez elle » alors qu'elle y est déjà, ou sortir sans but et se perdre. Plutôt que d'empêcher tout mouvement, il s'agit de sécuriser sans enfermer : la déambulation répond souvent à un besoin d'activité ou à une angoisse qu'il faut apaiser.

Concrètement, sécurisez les sorties avec des dispositifs discrets : verrous en hauteur ou hors du champ de vision, détecteurs d'ouverture de porte, sonnettes, et si besoin un bracelet ou médaillon de géolocalisation permettant de retrouver rapidement la personne en cas de sortie. Un contraste visuel (un tapis foncé devant la porte peut dissuader), un aménagement invitant à la déambulation en intérieur ou dans un jardin clos réduisent l'envie de sortir.

Prévenez le voisinage et les commerçants de proximité, qui pourront alerter en cas de besoin. Cousez ou glissez une carte d'identité et un contact dans les vêtements. Éliminez les dangers domestiques (gaz, produits toxiques, médicaments, objets coupants) rangés hors de portée. En cas de disparition, contactez immédiatement les secours : chaque minute compte.

À RETENIR

- Sécuriser sans enfermer : la déambulation répond à un besoin à apaiser.
- Verrous discrets, détecteurs d'ouverture, bracelet de géolocalisation.
- Aménager un espace de déambulation intérieur ou un jardin clos.
- Informer le voisinage et glisser un contact dans les vêtements.

06 Le syndrome crépusculaire — comment réagir

Le syndrome crépusculaire (ou « sundowning ») désigne une aggravation des troubles en fin de journée, à la tombée du jour : agitation, anxiété, confusion, déambulation, parfois agressivité. Ce phénomène, fréquent, s'explique par la fatigue accumulée, la baisse de luminosité qui perturbe les repères, la faim ou la perturbation de l'horloge biologique interne, souvent altérée par la maladie.

Pour l'atténuer, agissez sur l'environnement : maintenez une lumière suffisante et chaleureuse en fin de journée, fermez les rideaux avant la nuit pour éviter les reflets anxiogènes, réduisez le bruit et l'agitation à ces heures. Instaurez une routine apaisante en soirée (repas à heure fixe, activité calme, musique douce) et évitez les excitants (caféine) et les siestes trop longues en journée qui dérégleraient le sommeil.

Anticipez plutôt que de réagir dans l'urgence : proposez une activité rassurante avant l'apparition habituelle des symptômes. Accompagnez avec douceur, sans contrarier, en validant les émotions. Une bonne exposition à la lumière naturelle en journée aide à réguler l'horloge biologique. Si le syndrome est intense et récurrent, parlez-en au médecin, qui pourra vérifier l'absence de cause médicale sous-jacente.

À RETENIR

- Aggravation des troubles en fin de journée liée à fatigue et baisse de lumière.
- Maintenir une lumière chaleureuse le soir et fermer les rideaux avant la nuit.
- Instaurer une routine calme et éviter caféine et siestes trop longues.
- Favoriser l'exposition à la lumière naturelle en journée.

07 L'aidant : soutien, répit, plateformes

Accompagner un proche atteint d'Alzheimer est l'une des situations d'aidance les plus éprouvantes, sur le plan physique comme émotionnel. Le deuil anticipé, la culpabilité, l'épuisement guettent. Il est vital de ne pas rester seul : de nombreuses ressources existent pour vous soutenir. France Alzheimer, présente dans chaque département, propose formations gratuites des aidants, groupes de parole, café-mémoire et écoute téléphonique.

Le répit est indispensable. Les accueils de jour spécialisés Alzheimer offrent à la personne des activités adaptées et à l'aidant du temps pour souffler. Les plateformes d'accompagnement et de répit des aidants (PFR) informent, orientent et coordonnent les solutions. Le baluchonnage (relayage à domicile) permet de s'absenter plusieurs jours. Le droit au répit de l'APA finance une partie de ces solutions.

Activez pour vous-même les dispositifs de soutien : Mon Soutien Psy (jusqu'à 12 séances remboursées), bilan de santé gratuit, congé de proche aidant. Se former à la maladie aide énormément à mieux comprendre et donc à mieux réagir. Enfin, un accompagnement professionnel à domicile partage la charge au quotidien et vous permet de rester avant tout un conjoint, un enfant, plutôt qu'un soignant à temps plein.

À RETENIR

- S'appuyer sur France Alzheimer : formations, groupes de parole, écoute.
- Utiliser accueils de jour, baluchonnage et plateformes de répit (PFR).
- Activer pour soi Mon Soutien Psy et le congé de proche aidant.
- Se former à la maladie pour mieux comprendre et mieux réagir.

08 Anticiper la fin de la maladie à domicile

Aux stades avancés, la question du maintien à domicile jusqu'au bout se pose. C'est un choix légitime et possible, à condition d'un accompagnement renforcé. Les soins palliatifs à domicile, l'Hospitalisation À Domicile (HAD) et l'intervention coordonnée d'infirmiers, de médecins et d'aides à domicile permettent d'assurer confort et dignité dans le lieu de vie familial, souvent apaisant pour la personne.

Anticiper juridiquement est essentiel : les directives anticipées permettent d'exprimer par avance ses volontés sur les soins de fin de vie, et la désignation d'une personne de confiance garantit qu'un référent portera la parole du malade quand il ne pourra plus s'exprimer. Les mesures de protection juridique (habilitation familiale, curatelle, tutelle) sécurisent la gestion des affaires. Ces démarches se préparent idéalement tôt, dès le diagnostic.

L'accompagnement de fin de vie éprouve profondément les proches. N'hésitez pas à solliciter les équipes mobiles de soins palliatifs, le soutien psychologique et les bénévoles d'accompagnement. Préserver des moments de tendresse et de présence, au-delà des soins, compte plus que tout. Un accompagnement professionnel humain et coordonné soulage la famille pour qu'elle puisse vivre pleinement ces derniers moments.

À RETENIR

- Maintien à domicile possible avec soins palliatifs et HAD coordonnés.
- Rédiger les directives anticipées et désigner une personne de confiance.
- Mettre en place une mesure de protection juridique adaptée.
- S'entourer d'équipes de soins palliatifs et de soutien psychologique.

✓ Votre checklist récapitulative

- ☐ Situer le stade de la maladie pour anticiper les besoins et décisions.
- ☐ Adopter une communication bienveillante inspirée de l'Humanitude.
- ☐ Proposer des activités qui ont du sens (approche Montessori).
- ☐ Chercher la cause derrière chaque trouble du comportement.
- ☐ Sécuriser le domicile contre l'errance sans enfermer la personne.
- ☐ Anticiper le syndrome crépusculaire par l'environnement et la routine.
- ☐ S'appuyer sur France Alzheimer, le répit et Mon Soutien Psy.
- ☐ Préparer tôt les directives anticipées et la protection juridique.

Accompagner un proche atteint d'Alzheimer ne devrait jamais se faire seul. Les intervenants formés de Youdom Care vous épaulent au quotidien. Appelez le 01 84 80 72 97 ou rendez-vous sur youdom-care.com.

Nos coordinatrices vérifient gratuitement vos droits et montent les dossiers à votre place.

Réponse en moins de 2 h ouvrées · Visite à domicile gratuite · Sans engagement.

 **01 84 80 72 97**

Ce guide est fourni à titre informatif et ne se substitue pas à un conseil personnalisé. Informations à jour en 2026, susceptibles d'évoluer. © Youdom Care.